



表 37 ECMO 每日检查记录单 (D)

姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	____岁	床	____床	ECMO 模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV
上机时间	____月____日____时	已运行	____天____小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
D 模块：实验室与参数（参照当日最新结果）					
项目	目标范围	今日值	预警阈值 → 处理		
APTT	50-80s（无出血）,40-50s(有出血)	_____s	<40s→血栓风险,上调肝素>100s→出血风险,下调/停肝素		
ACT	160-200s(无出血),130-160s(有出血)	_____s	同上		
抗 Xa（如有）	0.3-0.5 IU/mL	_____IU/mL	>0.7→出血高风险；<0.2→血栓风险		
肝素剂量	—	_____U/kg/h	根据 APTT/ACT/抗 Xa 调整		
膜后血气（氧合器出口）	PaO ₂ 200-400mmHg	pH_____ PaO ₂ _____ PaCO ₂ _____	PaO ₂ <150→氧合器功能下降		
患者动脉血气	PaO ₂ 80-150mmHg, PaCO ₂ 35-45mmHg	pH_____ PaO ₂ _____ PaCO ₂ _____	PaO ₂ <70→提高 ECMO 流量/FiO ₂ ; PaO ₂ >300→警惕高氧损伤(VA/ECPR 尤其) PaCO ₂ 变化过快→脑血流风险		
血红蛋白（Hb）	≥8g/dL	_____g/dL	<7→输血（参照 ELSO 输血阈值）		
血小板（PLT）	> 50-80 ×10 ⁹ /L	_____×10 ⁹ /L	<50→出血风险高,考虑输注;<20→严重风险		
纤维蛋白原（FIB）	> 1.5-2.0g/L	_____g/L	<1.5→补充纤维蛋白原/冷沉淀		
D-二聚体	关注趋势	_____mg/L	持续升高→环路凝血/血栓形成风险		
乳酸	动态下降	_____mmol/L	>4 或持续不降/升高→灌注不足/病情恶化		
血浆游离 Hb（如有）	<50mg/dL	_____mg/dL	>50→溶血；排查泵头血栓/负压过大		
血糖	144-180mg/DL, (8-10 mmol/L)	_____mmol/L	<3.9 或>10→胰岛素调整		
核心体温	33-36°C(ECPR 亚低温), 常温:<37.7°C	_____□	>37.7→积极降温（发热增加脑氧耗）		

依据：ELSO 指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）。

用途：每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施